El ejercicio: lo que dicen los estudios

En pocas palabras, lo que se sabe del ejercicio. Su fisioterapeuta le indicará qué ejercicios hacer, cuánto y cómo avanzar.

El ejercicio y el dolor

- Hacer ejercicio con regularidad suele ayudar algo con el dolor y a moverse mejor. No es un efecto grande ni igual para todo el mundo.
- Al empezar es normal notar agujetas o algo más de dolor muscular. Suele pasar en unas semanas, y en los estudios el ejercicio no empeoró el dolor.

Moverse y cargar: músculos y tendones

- Si se deja de usar una pierna unos días, la fuerza se pierde muy rápido, incluso antes de que se note en el músculo. Moverse y cargar lo que se pueda ayuda a no perderla.
- En un tendón que duele, el ejercicio con carga es el tratamiento principal, y hay varias formas de hacerlo que funcionan.
- El entrenamiento de fuerza sigue funcionando con la edad: se gana fuerza aunque el músculo crezca menos.

Ánimo y sueño

- Si además se siente bajo de ánimo, moverse con regularidad (caminar, fuerza, yoga) mejora esos síntomas en los estudios, incluso a intensidad suave. No sustituye al tratamiento que le indique su médico.
- El ejercicio regular suele mejorar cómo siente que duerme, aunque no necesariamente le hará dormir más horas.

SI LE HAN DICHO QUE TIENE…

Si tiene una enfermedad reumática inflamatoria (artritis reumatoide, lupus…)

- Si tiene una enfermedad reumática inflamatoria, como artritis reumatoide o lupus, el ejercicio pautado no empeora la inflamación y le ayuda a ganar fuerza y a moverse mejor. Aún hay pocos estudios.
- En la artritis reumatoide, una sesión de ejercicio no empeoró el dolor en los estudios.

Si se marea o se le acelera el corazón al estar de pie (POTS)

- Un programa de ejercicio que empieza tumbado o sentado y avanza poco a poco hacia ejercicio de pie suele mejorar cómo tolera estar de pie y la parte física de su calidad de vida. No mejora todos los síntomas, ni a todo el mundo por igual.

Si tiene hipermovilidad articular

- El ejercicio de fuerza, subiendo la carga poco a poco, no suele aumentar el dolor y suele ayudar a que la articulación funcione mejor. La mejoría suele ser moderada, y al principio puede dejar agujetas que pasan.
- No hay un ejercicio «especial» para la hipermovilidad: los distintos programas que se han probado han dado resultados parecidos.

Durante el embarazo y después del parto

- Hacer ejercicio durante el embarazo o después del parto suele ayudar algo al estado de ánimo. Es un apoyo: si hay una depresión, no sustituye a su tratamiento.
- Entrenar el suelo pélvico durante el embarazo, antes de tener escapes de orina, hace menos probable tenerlos al final del embarazo y después del parto.
- Si después del parto le duele la espalda o la pelvis, el ejercicio, sobre todo de fuerza del tronco, ayuda a que mejore antes. Suele mejorar también con el tiempo.

Sus ejercicios

Resumen de estudios revisados. No sustituye a lo que le indiquen su fisioterapeuta o su médico: ante cualquier duda, pregúnteles.